Treino de habilidades

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica

Check-list: Medida da pressão arterial pelo método auscultatório.
Materiais necessários: álcool a 70%, algodão, bandeja, esfigmomanômetro, manguitos de diversos tamanhos, estetoscópio, fita métrica.

AÇÕES	OBSERVAÇÕES
□1. Higienizar as mãos[1]	
□2. Fazer a desinfecção da campânula/diafragma e das olivas do estetoscópio, com algodão embebido em álcool a 70%	
□3. Separar os materiais necessários para o procedimento e colocar na bandeja	
□4. Higienizar as mãos	
□5. Apresentar-se ao paciente e confirmar sua identidade usando dois identificadores[2], conforme política da instituição	
□6. Certificar-se de que o paciente NÃO: está com a bexiga cheia; praticou exercícios físicos, caminhada ou fisioterapia há pelo menos 90 min; ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou nos 30 minutos anteriores	
□7. Explicar o procedimento ao paciente: deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo; instruí-lo a não conversar durante o procedimento (o esclarecimento de dúvidas deverá ser realizado antes ou após o procedimento)	
□8. Higienizar as mãos	
□9. Medir a circunferência do braço. ***Método:*** com braço desnudo, fletido e mão na altura da cintura, meça a distância entre acrômio e olécrano e determine o ponto médio, a seguir estenda o braço ao longo do corpo e no ponto determinado meça a circunferência do braço. Com o valor obtido selecione o manguito de tamanho adequado ao braço (Tabela1)*	
□10. Posicionar o paciente: sentado, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (entre o 3º e o 5º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido	
□11. Localizar a artéria braquial por meio da palpação. O meio da bolsa de borracha do manguito deve ser posicionado sobre a artéria.	
□12. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital	
□13. Posicionar os olhos no mesmo nível do manômetro aneróide	
□14. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. ***Método:*** palpar o pulso radial e inflar o manguito até o desaparecimento do pulso, na sequência desinflar lentamente e identificar em quantos mmHg o pulso reaparece, (correspondente à estimativa da PA sistólica), desinflar e aguardar um minuto antes de iniciar a medida	

[1]Atenção aos 5 momentos de higienização das mãos: 1.Antes de tocar o paciente; 2.Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; 3.Após risco de exposição a fluidos corporais; 4.Após tocar o paciente; 5.Após tocar superfícies próximas ao paciente.
[2] Os identificadores podem ser: nome e data de nascimento.

□ 15. Colocar o estetoscópio nos ouvidos	
□ 16. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva	
□17. Inflar rapidamente de 10 em 10 mmHg até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido anteriormente	
□18. Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2mmHg/segundo)	
□19. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco, seguido de batidas regulares	
□20. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (Fase V de Korotkoff)	
□21. Continuar auscultando por mais 20 - 30 mmHg para confirmar o desaparecimento do som, depois libere todo o ar do manguito.	
□22. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons e anotar valores da sistólica/diastólica/zero	
□23. Informar os valores da pressão arterial obtidos para o paciente	
□24. Retirar o manguito do paciente	
□25. Higienizar as mãos	
□26. Checar a realização do procedimento e proceder a anotação de enfermagem (registrar no prontuário o valor exato da pressão arterial, sem "arredondamentos")[3]	
OBS: Na primeira avaliação do paciente, realiza a medida da pressão arterial em ambos os braços, respeitando intervalo mínimo de 1 minuto entre as aferições, compara os valores obtidos e identifica o braço com maior pressão arterial, definindo-o como braço de referência para as medidas subsequentes.	

Tabela 1. Dimensões da bolsa de borracha para diferentes circunferências de braço em crianças e adultos.

* Selecionar o manguito ideal: a largura da bolsa inflável deve corresponder a 40% da circunferência do braço e seu comprimento envolver pelo menos 80% do braço

Denominação do manguito	Circunferência do braço (cm)	Bolsa de borracha (cm)	
		Largura	Comprimento
Recém-nascido	≤ 6	3	6
Criança	6-15	5	15
Infantil	16-21	8	21
Adulto pequeno	22-26	10	24
Adulto	27-34	13	30
Adulto grande	35-44	16	38
Coxa	45-52	20	42

[3] Exemplo de anotação de enfermagem: 26/08/2020 – 08:00h – Realizada medida da pressão arterial pelo método auscultatório, em braço esquerdo, com paciente sentado na poltrona, com resultado igual a 118X66 mmHg. Nome/COREN.

Tabela 2. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade.

Classificação da PA	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120-139	e/ou	80-89
HA Estágio 1	140-159	e/ou	90-99
HA Estágio 2	160-179	e/ou	100-109
HA Estágio 3	≥ 180	e/ou	110

Bibliografia

1) Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol, 2025.
2) Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório – 2023. Arq Bras Cardiol. 2024

Atualizado por:	Adriele Delmiro de Souza, Juliana de Melo Mendes Germano e Rosely da Silva Matos Liberatori – 04/03/2026